

17/04/2026

Fármacos antidiabéticos e para controle do peso

Insulina NPH e regular são as duas que estão no SUS

E se associa as duas insulinas. O pico da NPH está dessincronizado com o pico pós prandial aí se associa as duas

Insulina basal que cobre a glicemia basal/ jejum

Glargina é ultralenta uma nanotecnologia para não fazer pico. E na DM2 se tem mais hipoglicemia no pós prandial pois a pessoa tem resistência, e para evitar picos tem a Glargina (diferença entre ela e as outras insulinas, que a Glargina não faz ter pico)

Ultrarrápida é para uma melhor conveniência para o paciente pois ela é aplicada no momento da refeição

Rápida/ regular e ultrarrápido → para glicemia pós prandial

Intermediária e ultralenta (NPH, glargina e determir) → é para glicemia de jejum

Sulfonilureias → Obriga o pâncreas a produzir mais insulina e aí a glicemia do paciente cai, aí ajusta a dose para não ter hipoglicemia

Metformina → Inibe produção de glicose pelo fígado (padrão ouro para DM2) → tem pouca interação medicamentosa, atua na produção de glicose pelo fígado e tem excreção renal quase na hora

3 efeitos colaterais → Do desconforto abdominal e diarreia, leva a perda de peso e LDL e triglicérides

No SUS hoje só tem Metformina (não pode tomar se o paciente é renal) e Sulfonilureias (não pode tomar se teve pancreatite)

Arcabose → pouco usada

Problema da Arcabose → causa muito desconforto intestinal gastrointestinal intensa, leva a flatulência

- Na dieta desse paciente precisa ter pouco carboidrato, e com pouco precisa tomar cuidado com a hipoglicemia

Glitazonas/ pioglitazona

- Atua na resistência insulínica

Efeitos colaterais → Causa muita retenção de líquido (ruim para pacientes obesos cardiopatas)

Glinidas → Pouco usadas e muito caras

Análogos de GLP-1

Mimetiza GLP-1

Gliptinas mantém o GLP-1 da pessoa ativo por mais tempo

E os análogos e a gliptinas não pode usar os dois juntos

Gliflozinas/ empaglifozinas

- Inibidores de SGLT 2 (diurético)
- Excreta glicose pela Urina

Pode aumentar risco de infecção urinária

Diminui a Volemia e faz as gliflozinas tornarem-se diuréticos de escolha para manutenção de pacientes com insuficiência cardíaca controlada (entre os tiazídicos e os poupadores de potássio)

Paciente diagnosticado o tratamento inicia com DM2 tratamento → dieta, exercício e metformina → Diminui glicemia (ainda tem insulina no pâncreas) → combiana diabéticos orais quando estabiliza → mantem a meta → perde função de célula beta → perde função de insulina endógena → ajusta dose de insulina → continua perdendo mais função de célula → toma glargina → perde cada vez mais e mais função de célula e aí a dose fica igual a do DM1

Glargina é a se escolha que o paciente tem e que pode pagar pois é mais caro

Dieta e atividade física é determinante para a piora da DM

No sus começa com metformina e depois associa com Sulfonilureias

A perda de peso tem três pilares e se um falhar os outros vão cair também

- Dieta
- Atividade física
- Medicamento

Apenas a metformina é muito menos eficaz sozinha, mas os três pilares juntos têm a melhor resultado

- O maior desafio é manter o resultado

Objetivos principais do controle do excesso de peso:

- Reduzir gradativamente o peso
- Manter o novo peso a longo do prazo
- Reduzir a gordura abdominal controlando fatores de risco associados
- Melhorar qualidade de vida

Farmacoterapia

Se classifica três grandes grupos de fármacos para o controle de peso

- Xenical/ orlistat → atuam sobre o sistema digestório inibindo a absorção de gordura
- Atuam no SNC modificando o apetite ou a conduta alimentar
- Antidiabéticos

Xenical/ orlistat

Inativa a ação da lipase pancreática e diminui até 30% a absorção dos triglicérides alimentar

Medicamento via oral

Efeitos colaterais: Aceleração do trânsito intestinal, flatulência, evacuação oleosa, urgência/ incontinência fecal

Indiretamente ajuda na reeducação alimentar, já que se a pessoa o consumir + gordura ela vai passar mal e ter os efeitos colaterais

Orlistat + MEV = resultados eficientes

Fármacos que atuam no SNC modificando o apetite ou a conduta alimentar – anorexígenos

Serotonina e noradrenalina modificam o apetite a satisfação sexual

Serotoninérgico/ nordrenérgico

Serotonina e noradrenalina fazem ter satisfação e sensação de saciedade

Sibutramina tem risco cardiovascular pois aumenta noradrenalina e ai aumenta FC

Sibutramina bloqueia o receptor de recaptura de serotonina e noradrenalina

Ai a pessoa tem mais saciedade

Sibutramina inibe a receptação da serotonina e da noradrenalina e ai diminui a ingestão alimentar e aumenta o gasto calórico

Efeitos colaterais: Boca seca, obstipação, taquicardia, sudorese, eventualmente aumento da PA

Serotoninérgico:

Fluoxetina é o primeiro inibidor a receptação da serotonina (obesos compulsivos, bulimia nervosa, deprimidos)

Efeitos colaterais: cefaleia, insônia, ansiedade, diminuição da libido

Prescrição Off Label é quando um fármaco é prescrito para algo que não é oficialmente indicado

Ai a fluoxetina é prescrita para emagrecer mesmo não sendo inicialmente para isso- ai ele é um off label

Noradrenérgico

Afepramona, Fenaterrina, Femproporex, Manzidol (são chamados de anorexígenos, na prova não cai os nomes)

- Diminuem a ingestão alimentar por ação noradrenérgica. Pacientes hiperfágicos

Efeitos colaterais: boca seca, insônia, taquicardia, ansiedade

Anticonvulsiantes

Topiramato → para pacientes com compulsão alimentar

Uso de antidiabéticos para obesidade

Efeitos do GLP-1 e, humanos

- Retarda esvaziamento gástrico
- Promove saciedade e reduz o apetite
- Faz célula alfa diminuir glucagon pós prandial ai diminui saída de glicose hepática (ouvir áudio 34 min)

Liraglutida tem meia vida maior e é muito parecida com o GLP-1 do próprio corpo
Liraglutida foi criada pelo diabetes

Liraglutida é resistente a enzima que quebra o GLP-1 ai a meia vida é maior
No fisiológico GLP-1 tem meia vida de 1 a 2 minutos e a Liraglutida tem meia vida maior

A indústria criou inibidor de DPP-4 que é o que destrói o GLP-1

Ver vídeo do pré aula

Genúvia vendia o dobro do que o análogo de GLP-1 (liraglutida) pois era injetável

Em 2011 a Anvisa cancela todos os fármacos que atuavam no sistema nervoso

Em 2017 volta os fármacos

Mas até aí volta as canetas emagrecedoras

Riscos das canetas emagrecedoras

Sexenda é liraglutida em dose alta

Riscos

- Pancreatite aguda (que é o principal fator de risco para o câncer de pâncreas)
- Câncer de pâncreas

A patente de liraglutida rompe e aí vem a Semaglutida (ozempic e Wegovy)
Wegovy é contraindicado a pacientes com neoplasias endócrinas. Mas ele é usado para perda de peso em termos legais e o Ozempic é apenas para diabetes e ele é Off Label para emagrecer. Se a pessoa toma Wegovy e tem câncer de endócrino a culpa é da indústria e se tomar ozempic a indústria não tem culpa

Mounjaro (Tirzepatida)

Agonista duplo de duas incretinas GLP-1 e GIP e mexe com várias outras coisas e tem um efeito emagrecedor muito maior

Esses fármacos reduzem riscos cardiovasculares em pessoas que tem riscos cardiovasculares

Rimonabanto

(Maconha, so que maconha da larica)

→ O fármaco é bloqueador de CB1 que é o que da fome

→ Na farmacovigilancia viram que aumenta risco de suicídio